

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病 Acute Lymphoid Leukemia, ALL				
編號	A31000-Q03-W-N22	制定者	R11 吳淑鈞	公布日期	111 年 08 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.2 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員能瞭解兒童急性淋巴性白血病的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科單位。

三、說明

（一）定義

白血病是白血球失去正常血液細胞應有的分化能力，而異常增生所致。不正常的白血球逐漸取代骨髓內正常的造血細胞，同時也影響紅血球及血小板的造血。急性淋巴性白血病為兒童最常見的癌症，好發於 2-7 歲。

（二）成因

多數白血病病因不明，可能致病的因素有：先天性疾病，基因突變（如唐氏症）、暴露於過量放射線之傷害、病毒感染有關、致癌化學物品的刺激。

（三）症狀

1. 發燒：癌細胞迅速成長，破壞迅速，會使得新陳代謝亢進，引起發燒。正常白血球無法形成，造成抵抗力差，易感染而發燒。
2. 貧血：臉色蒼白是最常見的症狀，疲倦、軟弱、食慾不振、體重減輕、呼吸困難。
3. 容易出血：身體任何系統都可能發生出血，容易出現瘀青或出血斑點等。
4. 頭疼痛：持續疼痛難忍，與正常的生長痛不同。

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/7

5. 器官腫大：白血球細胞侵犯到肝臟、脾臟、淋巴腺、胸腺等，造成器官腫大。

6. 淋巴腺腫大：發生於前、後頸部、腋窩或鼠蹊部。

（四）診斷與檢查

詢問詳細病史，身體檢查，最主要檢查是血液及骨髓抹片，抽血檢查各種血球的數目及白血球的形態。

1. 血液檢查：白血球的數目明顯增高、紅血球數及血比容都不足、血小板數目明顯降低。

2. 骨髓抽吸：是確定白血病的依據。

3. 腰椎穿刺檢查：白血病確定診斷後進行，以了解疾病是否已侵犯至腦、脊髓等中樞系統。

（五）分類

急性淋巴性白血病依免疫學標記，可分為 T 淋巴球型、B 淋巴球型和前 B 淋巴球型，包括帶有費城染色體者。急性淋巴性白血病(ALL)分成三群：標準危險群(standard risk)、高危險群(high risk)、最高危險群(very high risk)，給予輕重不同的治療。

（六）治療

1. 引導期：

給予 vincristine 和 prednisolone 是基本藥物，加上 L-asparaginase 或 anthracycline 來達到緩解骨髓內白血病細胞少於 5%，高危險群會加上 cytarabine(Ara-C)、Cyclophosphamide、mercaptopurine(6-MP)以增加緩解率，一般引導期為 4-6 星期。

2. 鞏固期：

換不同藥物，把殘留的癌細胞摧毀，常使用高劑量 methotrexate(MTX)、6-MP。

3. 再引導期：

以類似引導緩解的藥物再給一次，以 dexamethasone 取代 prednisolone，可增加 steroid 作用到腦部的量，減少中樞神經白血病。

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/7

4. 維持期：

維持期治療 2-3 年，維持期的治療以 MTX、6-MP 為主，搭配 vincristine、dexamethasone 使用。高危險群加上 cyclophosphamide、cytarabine。極高危險群以四對不同組合的藥物輪替使用。

5. 中樞神經預防療法：

中樞神經預防療法給予 MTX、Ara-C、hydrocortisone 三種藥物，進行脊髓鞘內注射(triple intrathecal therapy, TIT)。急性白血病給予中樞神經預防療法越早越好，在引導期、鞏固期、再引導期、維持期都有給予脊髓鞘內注射。盡量減少放射線治療，高危險群可能需要放射線治療。

(七) 護理問題

1. 易感染/與免疫系統受抑且白血球下降有關。
2. 易受傷害/骨髓抑制導致血小板下降有關。
3. 活動耐力不足/骨髓抑制導致紅血球下降有關。
4. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。
5. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。
6. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。
7. 焦慮感受/與對疾病及治療之知識缺乏有關。
8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(八) 護理措施

1. 易感染/與免疫系統受抑且白血球下降有關。
 - (1) 保護皮膚及黏膜之完整性，監測生命徵象。
 - (2) 教導病人與家屬訪客注意事項，如：在接近病人之前先洗手。
 - (3) 視需要限制訪客，減少病人的暴露及預防感染。
 - (4) 當白血球下降，抵抗力變弱時，給予保護性隔離。
 - (5) 教導病人及家屬感染的症狀與徵象，如：紅、腫、熱、痛、發燒。
 - (6) 教導免疫抑制的病人不可接種活性病毒疫苗，不可以和患水痘或麻疹的人接

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/7

觸。

2. 易受傷害/骨髓抑制導致血小板下降有關。

- (1) 避免費力的活動，避免受傷，預防造成出血。
- (2) 避免進食粗糙或堅硬的食物，以防口腔黏膜受損。
- (3) 觀察出血的症狀，如：皮膚、尿液、糞便等，有無顱內出血徵象（頭痛、複視、噴射式嘔吐）。
- (4) 減少不必要的皮膚穿刺。
- (5) 預防意外傷害發生。

3. 活動耐力不足/骨髓抑制導致紅血球下降有關。

- (1) 給予足夠的休息。
- (2) 採集中護理。
- (3) 評估病人活動體力程度，設計適合病人的活動，以達到休息的目的又防止退縮，如繪畫、說故事、閱讀、下棋等。
- (4) 安排年齡相仿、興趣相同，和同樣需要限制活動的室友。

4. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。

- (1) 注意口腔黏膜狀況，選擇質地柔軟的牙刷或軟綿棒，清潔口腔，避免出血。
- (2) 若有口腔破損，應避免進食過熱或酸性食物。
- (3) 依醫囑給予局部麻醉劑止痛，減少疼痛。
- (4) 依醫囑給予 mycostatin 漱口液減輕不適及異味，預防口腔黴菌感染。

5. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。

- (1) 每日量體重、評估病人進食情形。
- (2) 收集病人喜好的食物，設計編入餐飲計畫中。
- (3) 鼓勵進食高蛋白、高熱量的飲食。
- (4) 少量多餐進食。
- (5) 避免過熱或刺激性食物，給予較柔軟食物。
- (6) 依醫囑給予止吐劑使用。

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/7

6. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。

- (1) 先向病人及家屬說明落髮是藥物導致，給予心理準備。
- (2) 使病人及家屬了解落髮非永久性，停止治療後，頭髮會再生（若是高劑量放射線治療，頭髮也許可能永不再生）。
- (3) 告知病人及家屬，毛髮脫落的現象可能為全身性的。
- (4) 如為長髮可以先將頭髮剪短，減輕落髮時的衝擊。
- (5) 介紹可以戴假髮或是合宜的帽飾，鼓勵病人說出落髮的感受，介紹病友認識。

7. 焦慮感受/與對疾病及治療之知識缺乏有關。

- (1) 解釋各項檢查過程及目的。
- (2) 提供適切的解答及支持。
- (3) 做檢查時，盡可能陪伴在身旁。
- (4) 較小的兒童視情況允許攜帶自己的玩具，較大的兒童鼓勵參與檢查過程。

8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

- (1) 出院前，評估病人及家屬對有關的病因及治療了解程度，給予適當教導。
- (2) 提供家屬資料和照顧的方法，以便病人返家的照顧。
- (3) 教導必需回醫院接受診查的症狀，如：發燒、臉色蒼白、瘀斑等。
- (4) 教導有關治療所造成的長期影響。
- (5) 告知定期返診醫院的時間。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/7

六、參考資料

- (一) 中華民國兒童癌症基金會 (2022, 4 月 05 日) 兒童白血病。 <https://ccfroc.org.tw/node/37>
- (二) 曾紀瑩(2017)・兒童常見的癌症及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理（八版，979-985 頁）・華杏。
- (三) 劉英妹(2020)・兒童血液疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學（最新修訂版，9-35-9-44 頁）・永大。
- (四) Horton, T. M., Steuber, C. P., & Aster, J. C. (2022). Overview of the clinical presentation and diagnosis of acute lymphoblastic leukemia/lymphoma in children. UpToDate. Retrieved Jun 08, 2022, from https://www-uptodate-com.sw.lib.csmu.edu.tw/contents/overview-of-the-clinical-presentation-and-diagnosis-of-acute-lymphoblastic-leukemia-lymphoma-in-children?search=Acute%20Lymphoid%20Leukemia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

七、附件

(略)

主題名稱	兒童急性淋巴性白血病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N22	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
111.08.02	1.0	新制定	111 年 07 月 13 日護理長會議通過;111 年 08 月 02 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.1	更新第六項文獻參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過;112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	1.2	英文標題修訂	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過;114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。